ESTUDIANTE

EJE 3 · Nuevos desafíos de la salud y el cuidado: Aborda cambios epidemiológicos, demográficos y ambientales.

Enfermería comunitaria frente a la vulnerabilidad social.

Leguizamón Gloria.[1], Suarez Peña Genara.[2], Alba Bustamante Jenifer.[1]

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR- FACULTAD DE MEDICINA- CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

1 INTRODUCCIÓN

El Hogar Año Santo de Cáritas nace en 1975 (San telmo). En el cual concurren Hombres en situación de vulnerabilidad social.
Debido a las transformaciones socioeconómicas que enfrenta Argentina en el último tiempo han generado un incremento de personas en situación de calle , años posteriores esto era algo transitorio, con una rápida reinserción laboral y social, en la actualidad esta es una vulnerabilidad crónica y multidimensional.
Es por eso que el centro cuenta con más de 80 concurrentes.
Por ende la enfermería comunitaria es crucial para identificar necesidades alteradas y brindar intervenciones que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de estos grupos. (Esteve.2026)

2 OBJETIVOS

Relevar información sobre la población de concurrentes, hábitos de salud, condiciones operativas y detección de riesgos para el diseño de intervenciones comunitarias de enfermería.

- Determinar los factores de riesgo individuales, ambientales y psicosociales predominantes que afectan a la comunidad
- Evaluar los recursos físicos, materiales, la infraestructura y las dinámicas de funcionamiento del centro para determinar la factibilidad de ejecución del plan de cuidados comunitarios.

3 METODOLOGÍA

Nuestra experiencia inició con la valoración comunitaria cuyo objetivo se centra en evaluar las necesidades que afectan a esta población de adultos en situación de vulnerabilidad. Para recolectar datos se empleó un recorrido observacional dentro del centro y una entrevista con el coordinador de dicho lugar además se llevó a cabo encuestas , se realizó control de signos vitales , control de peso y talla. Con los datos recolectados se llevó a cabo tres talleres; de alimentación saludable, tabaquismo y autocuidado e higiene, el cual finalizó con preguntas para evaluar el grado de conocimiento adquirido por parte de los concurrentes.

4 RESULTADOS



Figura 1. Segundo encuentro se lleva a cabo la intervención comunitaria

Salud mental: 23.53%

Enf. Cronicas: 52, 94%

Enf. Infecciosas: 11.76%

Patologias Resp: 52, 94%

Qué se logró: Se generó un entorno seguro de confianza que permitió a los participantes abrirse, comunicar sus vivencias y sentirse valorados. Rompieron el aislamiento inicial, expresaron sus emociones libremente y experimentaron el alivio de ser finalmente escuchados y visibilizados.

Qué dificultades hubo: El mayor obstáculo fue la reticencia inicial. Los hombres adoptan una actitud cerrada y pasiva: aunque prestaban atención, no querían hablar. A esto se sumaron momentos de dispersión y breves lapsos de atención que exigieron paciencia, flexibilidad y dinamismo en la comunicación. También un obstáculo fue el poco tiempo de campo práctico.

Qué se aprendió: Aprendimos a reconocer la fragilidad y el sufrimiento acumulado detrás de sus resistencias. Confirmamos su profunda necesidad de ser comprendidos, respetados y reconocidos como personas con valor y utilidad social. En definitiva, la experiencia reafirmó el verdadero rol de la enfermería: una práctica empática que trasciende la técnica para humanizar la atención y restituir la dignidad.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

La intervención en el Hogar Año Santo combinó la educación sobre **tabaquismo, alimentación y autocuidado** con un espacio de escucha empática. Al sentirse visibilizados, los hombres rompieron el aislamiento, se abrieron a conversar y fortalecieron lazos entre pares.

Se lograron los objetivos educativos e integrales, alcanzando cohesión comunitaria, aunque el tiempo acotado limita evaluar el impacto sostenido.

6 APORTE A ENFERMERÍA

La intervención realiza un aporte fundamental a la enfermería al trasladar su práctica directamente al territorio, valorando no solo el estado de salud individual, sino la totalidad de los **Determinantes Sociales de la Salud** que condicionan el proceso salud-enfermedad.

El cuidado en una comunidad vulnerada restituye la dignidad, promueve el bienestar integral y reconstruye el tejido social.

7 REFERENCIAS

Estebe. A. (2026). Enfermería comunitaria frente a la vulnerabilidad social. https://revistamedica.com/enfermeria-comunitaria-frente-vulnerabilidad-social-enfoque-integral-promocion/

Caritas. (2018) . Cáritas Buenos Aires inaugurará un hogar para hombres en situación de calle.

Contacto: g.leguizamon1@usal.edu.ar
albabustamante.jenifermelany@usal.edu.ar
S.genara@usal.edu.ar